急性肾炎综合征：血尿（必备且突出、＞3/HP）、蛋白尿、水肿和高血压（GFR↓致水钠潴留→多从眼睑颜面部开始“憋出来的”）（2010、2016、2018、2019、2021、2023、2024、2026）

	急性肾炎（2010、2014、2016、2020、2023）	急进性肾炎（2010、2022）
名字	急性弥漫增生性肾炎 毛细血管内增生性肾炎（2016） 链球菌感染后性肾炎（2011）	快速进行性肾炎 毛细血管外增生性肾炎 新月体性肾炎
增生	内皮细胞、系膜细胞	肾小囊壁层上皮细胞“闭月”
机制和荧光	原位或循环免疫复合物（2011） 颗粒状	Ⅰ-抗基膜型 GBM（原位）：线状 Ⅱ-免疫复合物型（原位或循环）：颗粒状 Ⅲ-免疫反应缺乏型（ANCA）：无荧光“3 型安卡无免疫”
好发年龄	儿童、青年	青年、中老年
前驱感染	多有，起病前 1~3 周上感等	多有，起病前 1~3 周上感等
肾功能减退	多不明显（Cr 多＜200、贫血多无或轻）	早期急剧恶化（Cr＞200、贫血有甚至中度及以上）
补体 C3	↓且 8 周内恢复（特点）	Ⅱ型持续↓
治疗	对症 （不用激素+环磷酰胺，2016）	强化疗法配合泼尼松+环磷酰胺 ①血浆置换强化：Ⅰ、Ⅲ型，肺出血如 Goodpasture 首选血浆置换“好怕医生抽血” ②甲泼尼龙冲击强化：Ⅱ、Ⅲ型“三心二意激素强”

肾病综合征：大量蛋白尿（必备、多+++或＞3.5）、低蛋白血症（必备、＜30）、水肿（血浆胶渗压↓）、高脂血症（2010、2015、2020、2024、2026）

	脂性肾病（2011、2020）	膜性肾病（2015）	系膜增生性肾炎	系膜毛细血管性肾炎
名字	微小病变性肾病，足突病 “足球小子脏”	“中老年历经磨难吃鸡丁”		膜增生性肾炎
病理	光镜肾小球无明显异常（2023） 近端小管脂肪变性 肾小囊脏层上皮细胞足突融合消失	基膜明显增厚 钉状突起、齿梳样、虫蚀样空隙 肾小囊脏层上皮细胞足突融合消失	系膜细胞和基质增生	系膜细胞和基质增生 并插入基膜和内皮间致双轨/分层征
免疫荧光	无（T 细胞免疫）	颗粒状	颗粒状	颗粒状
好发年龄	儿童（最常见）、青年	中老年	青年	青年
表现	典型肾病综合征（2011、2020）	最易肾静脉血栓	几乎伴血尿	几乎伴血尿、C3 持续↓
初治	单用激素 （8~12 周好转，2011、2020）	激素+环磷酰胺 （2015）	单用激素	激素+环磷酰胺 （疗效差）